



HỘI NGHỊ KHOA HỌC FMC - 2026

TÓM TẮT BÁO CÁO KHOA HỌC

CHUẨN ĐIỀU TRỊ CỦA AI? SAI LỆCH CỦA LLM THEO CHUẨN NƯỚC NGOÀI VÀ PHIÊN BẢN CŨ SO VỚI HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN CỦA BỘ Y TẾ VIỆT NAM

Ngô Bình Minh¹, Ngô Bình Thống², Trần Đoàn Mai Hương³

¹Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam;

²Khoa Y, Trường Đại học Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng, Việt Nam;

³Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Tác giả liên hệ: Ngô Bình Minh, ngobinhminh.st@tdtu.edu.vn

ĐẶT VẤN ĐỀ: Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể nêu liều thuốc hoặc ngưỡng chẩn đoán theo chuẩn nước ngoài hoặc phiên bản cũ thay vì hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế (BYT). Con số có thật ở hướng dẫn khác nên khó nhận ra. Mức độ và nguồn gốc sai lệch chưa rõ.

MỤC TIÊU: Thí điểm phương pháp đo tỉ lệ đúng và truy nguồn câu sai (đối chiếu mức trùng ngẫu nhiên), theo ngôn ngữ và điều kiện hỏi.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Thiết kế thí điểm: phân tích 61 khuyến cáo chọn chủ đích (trong 65) thuộc 12 văn bản BYT còn hiệu lực, trích nguyên văn kèm số trang. Ba nhóm: xung đột (20, khác ít nhất một chuẩn nước ngoài có tên; trong đó 15 có môi: giá trị sai đặt trước, để ước tính mức trùng ngẫu nhiên), phiên bản (20, có bản BYT cũ), đối chứng (21 khuyến cáo còn lại, trùng chuẩn nước ngoài). Qwen3-8B (mô hình mở nhỏ, lượng tử hóa bốn bit, chạy trên laptop) trả lời ngắn bằng tiếng Việt và tiếng Anh ở ba điều kiện: không nêu quốc gia, nêu BYT, kèm đoạn hướng dẫn. Chấm theo quy tắc định trước; chỉ AI (Claude) kiểm tra đoạn trích và 390 câu trả lời ngắn (hai lượt chấm mù, AI phân xử, cho phân tích độ nhạy). Khoảng tin cậy (KTC) 95% Clopper–Pearson; kiểm định McNemar chính xác ghép cặp giữa nêu BYT và kèm đoạn (khám phá, thêm sau khi mở kết quả).



KẾT QUẢ: Tiếng Việt, nêu BYT: nhóm xung đột đúng 7/20 (KTC 95%: 15,4%–59,2%); 2 trùng chuẩn nước ngoài, 7 không khớp nguồn đã ghi nhận, 4 câu bộ châm không đọc được giá trị (phân tích độ nhảy: đúng 8/20); nhóm đối chứng đúng 9/21; nhóm phiên bản 3/20 trùng bản cũ. Ở 15 khuyến cáo có môi: 2 trùng chuẩn nước ngoài, 0 trùng môi. Nhóm xung đột, tiếng Việt: không nêu quốc gia đúng 2/20; kèm đoạn 13/20; so với nêu BYT: 9 sai thành đúng, 3 đúng thành sai (McNemar, khám phá: $p = 0,15$). Cùng nhóm, tiếng Anh, ba điều kiện, đúng: 3/20, 5/20, 13/20 (McNemar, khám phá: $p = 0,02$).

KẾT LUẬN: Phần lớn câu sai không khớp nguồn đã ghi nhận; chưa cho thấy trùng chuẩn nước ngoài vượt mức trùng môi. Khi nêu BYT, nhóm đối chứng cũng đúng chưa đến một nửa. Kèm đoạn, đúng nhiều hơn nhưng vẫn còn sai; người học và thầy thuốc cần đối chiếu con số LLM đưa ra với hướng dẫn BYT hiện hành. Hạn chế: mẫu nhỏ chọn chủ đích, một mô hình, chỉ AI kiểm tra, chưa có bác sĩ duyệt, nhiều môi kém hợp lý; câu đúng có thể trùng chuẩn nước ngoài khác. Tiếp theo: nghiên cứu chính (sẽ đăng ký trước) trên kho hướng dẫn BYT hiện hành, nhiều mô hình mở.

TỪ KHÓA: mô hình ngôn ngữ lớn; hướng dẫn chẩn đoán và điều trị; bộ y tế; trí tuệ nhân tạo; đánh giá mô hình

HÌNH THỨC BÁO CÁO: Oral

LĨNH VỰC: AI và Chuyển đổi số trong Y tế và Giáo dục Y khoa

GHI CHÚ: Bài chưa được đăng trên tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế.